

①の使い分けは腫瘍組織のPD-L1の発現による。すなわちPD-L1陰性もしくは不明の場合は、nivolumabもしくはatezolizumabを、PD-L1陽性で、一次治療でpembrolizumabを使用しなかった場合は、これら3剤どれもが使用可能である。一次治療でpembrolizumabを使用した場合の二次治療治療薬は②を選択する。一次治療で免疫チェックポイント阻害薬を使用した場合は、二次治療でPSが良好であれば、DTX+血管新生阻害薬であるramucirumabが弱く推奨されるが、PSがやや不良例ならびに75歳以上の高齢者には併用した治療を行う根拠は明確ではなく、ramucirumabを併用した治療を行わないよう弱く推奨する。

iii) 癌性胸膜炎

胸腔ドレーンによる胸水排液後に talc、ビシパニールなどで胸膜癒着術を行う。急速な胸水排液は再膨張性肺水腫のリスクがあり避ける。

iv) 骨転移

疼痛がある場合、病的骨折が危惧される場合は放射線照射を行う。骨転移による骨関連有害事象（SRE）予防には、ビスホスホネート製剤、あるいは抗RANKL抗体が有効である。

v) 脳転移

定位放射線治療を含む放射線照射を行う。晩発性の副作用があるため、転移箇所が少ない場合は定位放射線治療や集光照射を選択するが、多発の場合には全脳照射が行われる。脳浮腫に対してはステロイド、あるいは血管新生阻害薬であるbevacizumabの有効性が報告されている。

予 後

非小細胞肺癌の予後は病期によって異なる。手術症例の5年生存率は、臨床病期ⅠA期82%、ⅠB期66.1%、ⅡA期54.5%、ⅡB期46.4%、ⅢA期42.8%、ⅢB期40.3%、Ⅳ期31.4%である（肺癌登録合同委員会の2004年切除例）⁵⁾。手術不能Ⅲ期の非小細胞肺癌の5年生存率は15~20%であったが、durvalumabによる維持療法により5年生存率は42.9%、生存中央値は47.5ヵ月と大きく改善された。Ⅳ期の非小細胞肺癌は薬物療法での根治は困難であり、細胞傷害性抗癌薬では12~14ヵ月程度、ドライバー遺伝子変異陽性例では24~30ヵ月程度、免疫チェックポイント阻害薬で約24ヵ月程度である。なお、免疫チェックポイント阻害薬の有効症例の一部には長期生存例が報告されているが、予後予測因子については明らかでない。

3

扁平上皮癌（PD-L1 強陽性肺癌を含む） squamous cell carcinoma

到達目標

- 扁平上皮癌の病因・病態および疫学を説明できる
- 扁平上皮癌の病理像および検査を説明できる
- 扁平上皮癌の治療について病期、PD-L1発現ごとに理解し説明できる

病因・病態・疫学

a 病因・病態

喫煙習慣は肺癌の主な原因となることがわかっており、日本人喫煙者の相対リスクは男性で4.4倍、女性で2.8倍であるとの報告がある。また扁平上皮癌については男性で11.7倍、女性で11.3倍の相対リスクといわれており、肺癌の中でも喫煙リスクの高い疾患であると知られている。

b 疫学

がん情報サービスでは2020年の肺癌罹患数は120,759例であり、日本における癌罹患数の第2位にあたる。死亡数は2023年は75,762件で第1位であり、他癌種と比較して死亡転帰にかかわる可能性の高い癌種である。

症候・身体所見

初期は症候や身体所見は認めないことがほとんどであるが進行すると咳嗽や喀痰、血痰が出現する。また進行するに従い骨転移に伴う疼痛や脳転移に伴う麻痺症状・嘔気および意識障害などの遠隔転移による症状が出現する場合がある。

診断・検査

a 病理

扁平上皮癌とは、角化または細胞間橋を伴う悪性上皮腫瘍を指し、腫瘍細胞はシート状に増殖し、細胞間橋の形成がみられる。細胞質が好酸性となり細胞自体が細長くなるのは角化傾向を反映している。扁平上皮癌は角化型、非角化型、および類基底細胞型の3種類の亜分類され、非角化型の場合、低分化型腺癌や大細胞癌との鑑別が重要となる。形態学評価が困難な場合免疫染色を行うこと推奨されており、扁平上皮癌マーカーとしてp40、腺癌マーカーとしてTTF-1が鑑別に有用であると報告されているが、それらにNapsin A、CK5/6を併用するマルチプレックス免疫染色法についても報告されている。

b 腫瘍マーカー

肺扁平上皮癌で主に使用されている腫瘍マーカーはSCC抗原およびCYFRAであり、肺扁平上皮癌における陽性率は臨床病期にもよるがⅣ期肺癌においては